PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

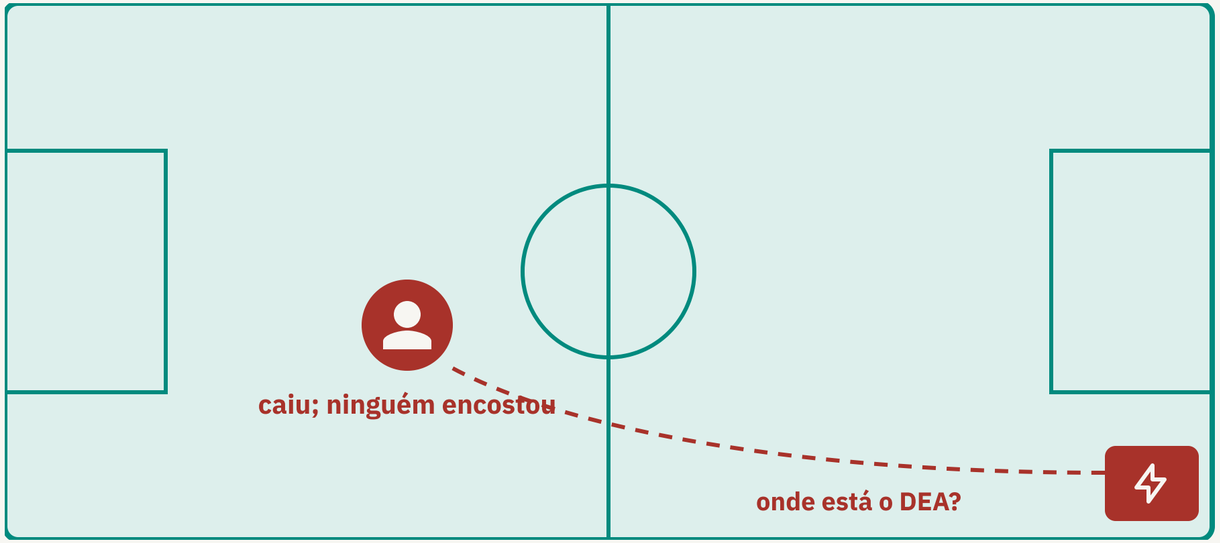
Emergência em campo

Plano escrito, reanimação e o que não é parada

Medicina Esportiva Clínica

SÁBADO DE MANHÃ, CAMPO ALUGADO

Um menino cai no meio do primeiro tempo



Decidido antes do jogo

- quem vai primeiro
- onde está o desfibrilador
- quem liga
- quem abre o portão

O PROCEDIMENTO

Seis passos, metade antes da queda

Antes da queda

1. **Plano escrito**
2. **Desfibrilador no lugar**

Na queda

3. **Reconhecer e comprimir**
4. **Chocar e voltar**

Depois

5. **Transferir e registrar**
6. **Ensaiar, de novo**

> A parte que decide o desfecho é a parte administrativa, feita numa terça-feira qualquer. Nada aqui substitui o curso presencial de suporte básico de vida.

Sete linhas, sete nomes próprios

Plano de emergência

		nome
Quem lidera	olha o relógio, distribui tarefas; não comprime	
Quem comprime	e quem é o segundo: troca a cada dois minutos	
Quem busca o desfibrilador	sai correndo sem esperar ordem	
Quem liga para o 192	com endereço, referência e portão escritos na folha	
Quem abre o portão	e conduz a ambulância até o atleta	
Quem afasta as pessoas	e protege a imagem do atleta	
Quem cuida do grupo	atletas e famílias que viram a queda	

> O teste: entregue a folha a quem não estava na reunião. Se não souber o que fazer, existe uma folha, não um plano.

PASSO DOIS: O DESFIBRILADOR

O critério de posicionamento é tempo



A meta

da queda ao primeiro choque, contando a corrida até o aparelho

Qualquer pessoa pode usar

o aparelho só choca ritmo chocável

Verificação

- bateria na validade
- pás na validade
- checagem registrada

Distância se mede em segundos de corrida. DEA trancado na diretoria é DEA que não existe. A primeira vez que alguém abre a maleta não pode ser com um atleta no chão.

Força-tarefa americana, Prehosp Emerg Care 2007 · Lei Lucas, 13.722/2018

Não responde e não respira normalmente: comprime

100 a 120

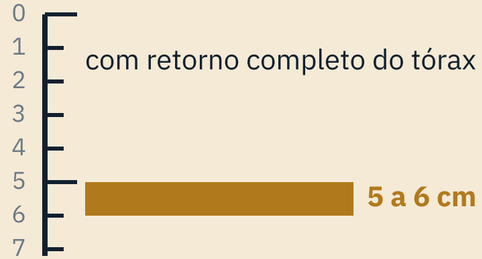
compressões por minuto



no ritmo, sem pausa

5 a 6 cm

de profundidade no adulto



2 min

troca de quem comprime



Grite e dispare duas tarefas ao mesmo tempo: “traz o DEA” e “liga 192”. Quem não é treinado em ventilação faz compressão contínua.

Diretriz americana de ressuscitação, Circulation 2025

O que aparece em quase todo vídeo

compressão contínua

esquema



✕ Procurar pulso

leigos e profissionais erram; cada segundo nisso é sem compressão

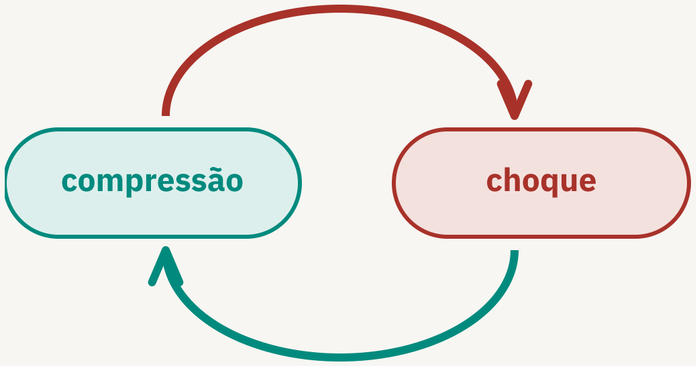
✕ Esperar o médico

pode estar no vestiário, ou não existir; quem está ao lado começa

✕ Levar para fora do campo

a reanimação acontece onde o atleta está

O que atrasa as pás, e a solução



volta a comprimir na hora, sem checar pulso

Tórax molhado
→ secar rápido

Muito pelo onde vão as pás
→ lâmina da maleta

Adesivo de medicação
→ retirar e limpar

Dispositivo implantado
→ pá alguns centímetros ao lado

Criança sem pá pediátrica
→ usar a de adulto

“Choque não indicado”
→ continuar comprimindo

> Depois do choque, volta a comprimir na hora, sem checar pulso. Quem comprime não para enquanto outro cola as pás.

PASSO CINCO: O QUE QUASE TODO MUNDO ESQUECE

Transferir, registrar, cuidar de quem ficou

A transferência, numa frase

hora da queda

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

hora da primeira compressão

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

choques dados

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

estado agora

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Quem fala

uma pessoa designada

família por telefone, não pelo story

O registro

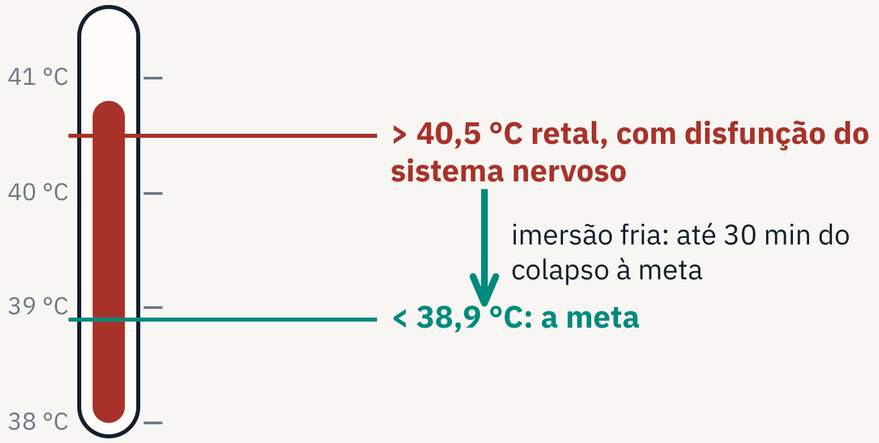
no mesmo dia

horários, choques, quem fez o quê

O grupo que viu o colega cair faz parte do atendimento. Dias depois, revisão curta: o que travou e quanto demorou cada elo.

A EMERGÊNCIA NÃO CARDÍACA QUE MAIS SE TRATA ERRADO

Golpe de calor: resfriar primeiro, transportar depois



1 Resfriar

caixa d'água, banheira inflável, tanque: água, gelo, corpo dentro

2 Transportar

depois de chegar à meta, não antes

A medida retal é a única confiável em quem está se exercitando. Caixa d'água, banheira inflável, tanque: água, gelo, corpo dentro, antes da ambulância.

Posicionamento da NATA, J Athl Train 2015

AS OUTRAS EMERGÊNCIAS

Uma linha para cada

Hipoglicemia

consciente: açúcar pela boca; inconsciente: nada pela boca, 192

Anafilaxia

adrenalina intramuscular na coxa, já; dispositivo no local do treino

Lesão cervical

não mover, não tirar capacete; na parada, comprimir vem antes

Engasgo

tosse eficaz, deixa tossir; não passa ar, desobstrução

Convulsão

protege a cabeça, nada na boca; passou de 5 min, emergência

Fratura, luxação

imobiliza como está; não reduz em campo

PASSO SEIS: ENSAIAR

O que transforma papel em plano

15 min

com cronômetro

- alguém deita no gramado
- a equipe executa cada linha da folha
- por trimestre, e com gente nova

Antes de cada jogo fora

- **onde está o DEA daqui?**
- **qual o endereço e o portão?**
- **tem ambulância, e até que horas?**
- **qual o hospital de referência?**

> O cronômetro costuma mostrar a mesma coisa: o DEA demora mais do que todo mundo achava.

A DIVISÃO MAIS HORIZONTAL DO MÓDULO

Plano escrito, desfibrilador perto, ensaio marcado

- Caiu sem contato e não responde: comprime e busca o DEA
- Golpe de calor: resfria no local antes de transportar
- Plano que nunca foi ensaiado não é plano

Médico

Coordena a reanimação e o atendimento, quando houver.

Quem estiver mais perto

Reconhece e comprime. Cada um executa a sua linha da folha.

A gestão

DEA conferido, plano, capacitação e ensaio.

O mínimo viável custa perto de zero: telefone, endereço, alguém que comprime, portão aberto.